Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

CAMPAGNE QUALITÉ

EN BREF

Période couverte	Campagne réalisée	Établissements accompagnés	Bénéficiaires
2023 – 2025	**Nov. 2025 – Jan. 2026**	**171 ESMS · 102 associations**	**8 500 personnes**

MÉTHODE D'ÉVALUATION

APPROCHE

Qualitative — expérience utilisateurs

PUBLIC CIBLE

Professionnels ESMS

ÉCHANTILLON

40 entretiens semi-directifs (30 min)

STRATÉGIE

Stratifié par type, public, géographie

OUTILS

Parcours utilisateur + grille d'entretien

ANALYSE

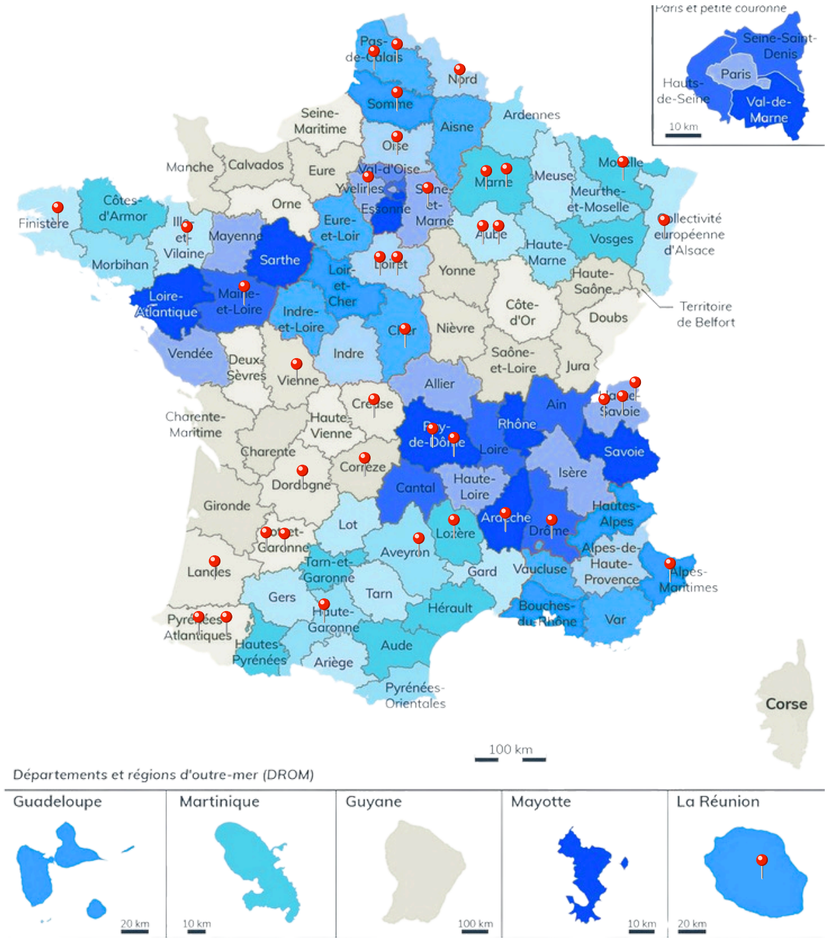
Arbre d'analyse + données chiffrées (% et score)

SECTEURS

Secteur Handicap · Secteur Séniors

CARTOGRAPHIE

Les entretiens réalisés (voir carte)



SYNTHÈSE EXÉCUTIVE — TOUS LES RÉSULTATS

ACCÈS SANTÉ

92%

Établissements en rupture complète de soins avant DOTR

ACCÈS SANTÉ

2,5/3

Adhésion des acteurs à la mise en place de la solution

ORGANISATIONNEL

87,5%

Contribution au soutien des équipes

FONCTIONNEL

88%

Satisfaction technique des outils

FONCTIONNEL

3,9/5

Facilité de prise en main des outils

ORGANISATIONNEL

82%

Participation à la consolidation des outils et process réglementaires

ORGANISATIONNEL

90%

Couverture médicale

ORGANISATIONNEL

82,5%

Renforcement de la coordination entre les acteurs

ORGANISATIONNEL

72%

Contribution à la préparation et au suivi des évaluations HAS

QUALITÉ & SOINS

90%

Amélioration qualité & continuité des soins

QUALITÉ & SOINS

75%

Professionnels ayant développé leurs compétences

ORGANISATIONNEL

90%

Sécurisation et mise en conformité des prescriptions et du circuit du médicament

CATÉGORIE 1 · IMPACTS SUR L'ACCÈS À LA SANTÉ

RÉSULTATS

1.1 · RUPTURE DE SOINS PRÉEXISTANTE

92%

des participants étaient en situation de rupture de soins médicaux avant la mise en place de la solution, caractérisée par une absence prolongée de médecin ou une continuité des soins insuffisante.
Causes évoquées : départs retraite non remplacés, intérim sans continuité, territoires ruraux sous-dotés

1.2 · NIVEAU D'ADHÉSION DES ACTEURS À LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION — SCORE MOYEN PONDÉRÉ 2,5/3

AU DÉMARRAGE : 1,5/3

Réticences à l'usage de la télémédecine
Freins culturels et organisationnels à la télémédecine
Difficultés d'appropriation par les familles et les professionnels

APRÈS STABILISATION : 3/3

Bilan très positif dès les six premiers mois
Forte satisfaction et volonté de maintenir le système actuel
Fidélité des équipes et des familles au médecin

CONCLUSION Le score traduit une adhésion consolidée si le déploiement est accompagné et piloté.

AXES D'AMÉLIORATION

→ Affirmer le positionnement stratégique du dispositif (indicateurs d'impact, rapports d'activité)

→ Promouvoir la mutualisation inter-établissements (planning mutualisé, gestion centralisée)

→ Mieux accompagner les gouvernances associatives (outils médico-économiques)

→ Formaliser un kit de déploiement clé en main (RACI, feuille de route 6 mois)

→ Renforcer la communication auprès des familles (kit de communication, FALC)

VERBATIMS TERRAIN

"On ne veut pas changer de système, c'est du vrai travail"

Chef de service — Secteur Séniors

"J'espère que ça va continuer vu le contexte dans la région"

Infirmière — Secteur Handicap

"On a eu beaucoup de freins même pour récupérer les consentements"

Directrice — Secteur Handicap

"Le médecin a gagné la confiance des professionnels"

Responsable de pôle — Secteur Handicap

"On avait une exigence ressentie des deux côtés, déploiement finalement très fluide malgré les craintes mais ça roule !"

Chef de service — Secteur Handicap

CATÉGORIE 2 · IMPACTS FONCTIONNELS

RÉSULTATS

2.1 · FACILITÉ DE PRISE EN MAIN — Score 3,9/5

3,9/5

✓ Plateforme ludique, ergonomique une fois maîtrisée
✓ Outils connectés pratiques & qualitatifs
△ Pas toujours intuitive au démarrage
△ Turn-over → formations répétées nécessaires

2.2 · SATISFACTION DES BESOINS TECHNIQUES — 88%

88%

✓ Délais de réponse rapides à immédiats
✓ Support disponible, efficace, à l'écoute
✓ Responsable régional = levier clé de déploiement
△ Besoins d'interopérabilité & équipements spécifiques

CONCLUSION

La réactivité constitue un point fort majeur, avec un haut niveau de confiance et de satisfaction des utilisateurs.

AXES D'AMÉLIORATION

→ Structurer la formation et l'appropriation des outils : Parcours de formation modulaire, Formats courts (tutoriels vidéo, fiches réflexes).

→ Fluidifier l'intégration technique : Kit nouvel utilisateur + session trimestrielle ouverte pour les intérimaires + protocole d'accès anticipé.

→ Simplifier l'expérience utilisateur : onboarding guidé intégré.

→ Renforcer l'accompagnement organisationnel.

VERBATIMS TERRAIN

"On a eu rapidement une bonne prise en main de la plateforme et des outils connectés du sac à dos"

Chef de service — Secteur Handicap

"Les infirmières intérimaires ne sont pas forcément formées sur les outils, il faudrait prévoir un support plateforme et outils pour formations"

Secrétaire médicale — Secteur Séniors

"Au départ on a pataugé un peu avec le médecin mais ça s'est bien passé, l'infirmière coordinatrice DOTR nous a beaucoup aidé"

Chef de service paramédicale — Secteur Handicap

"L'assistance technique s'est toujours bien passée, on a un très bon accueil et des solutions, l'aide technique est très efficace"

Infirmier en pratiques avancées — Secteur Handicap

"Plateforme très ludique, on a vraiment des personnes en face qui sont dispos"

Chef de service — Secteur Handicap

CATÉGORIE 3 · IMPACTS ORGANISATIONNELS

RÉSULTATS

3.1 · COUVERTURE MÉDICALES DES BESOINS — 90%

90%

Axe le plus cité. Accès médecin référent là où il n'existait pas. Renouvellements prescriptions, ajustements thérapeutiques, pathologies chroniques, réduction hospitalisations. Spécialités : MG, Psychiatrie, MPR, Coordination, Prévention.

3.2 · PLUS-VALUE ORGANISATIONNELLE

82,5% Renforcement de la coordination entre les acteurs

87,5% Contribution au soutien des équipes

3.3 · CONSOLIDATION OUTILS RÉGLEMENTAIRES — 82%

85%	90%	80%	72%
Formalisation outils	Sécurisation prescriptions	Structuration process	Préparation HAS/GIR

CONCLUSION

La solution contribue au developpement d'un harmonisation organisationnelle majeure : structuration des temps médicaux, coordination pluridisciplinaire renforcée, conformité réglementaire consolidée.

AXES D'AMÉLIORATION

→ Mesurer l'impact médico-économique (taux d'hospitalisations, déplacements évités, calcul des actes realisé)
→ Formaliser un modèle organisationnel reproductible (séquence type : brief-actes-débrief)
→ Clarifier la charte du médecin coordonnateur vs médecin traitant
→ Consolider l'organisation des remplacements
→ Capitaliser sur l'impact qualité et conformité : Module Appui qualité aligné référentiel HAS.

VERBATIMS TERRAIN

"60 résidents sans suivi pendant plus d'un an, nos stats démontrent clairement les impacts de l'avis médical, on a moins de recours aux urgences et d'hospitalisations"
Infirmier en pratiques avancées — Secteur Séniors

"C'est repérant pour tout le monde, ça a répondu à mes exigences : évaluation / prescription / réévaluation processus, on enlève tous les éléments qui vont venir parasiter"
Infirmière coordinatrice — Secteur Handicap

"C'est chronométré, il faut des temps efficaces, efficients. GIR et PATHOS super travail, on s'entend très bien, on a les mêmes valeurs, ça match !"
Chef de service — Secteur Séniors

"Pour le suivi administratif c'est génial, on ne court plus après les infos ! Ça m'a permis de rebaliser le lien IDE / médecin prescripteur"
Chef de service — Secteur Handicap

"L'intérêt c'est une vraie lecture sécurisée sur la traçabilité des prescriptions, on est plus dans les clous avec la réglementation"
Chef de service — Secteur Handicap

CATÉGORIE 4 · QUALITÉ & CONTINUITÉ DES SOINS

RÉSULTATS

4.1 · AMÉLIORATION QUALITÉ & CONTINUITÉ DES SOINS — 90%

90%

- Maintien du suivi médical dans des contextes de tension médicale
- Réduction ruptures de soins & hospitalisations évitables
- Réévaluation prescriptions (ALD & non ALD)
- Développement approches non médicamenteuses
- Relation de confiance durable — médecin référent
- Distanciel perçu comme levier qualitatif (temps médicaux mieux préparés et ciblés)

4.2 · PROFESSIONNELS AYANT DÉVELOPPÉ LEURS COMPÉTENCES — 75% (30/40)

75%

- Renforcement compétences cliniques (obs., analyse, transmission)
- Montée en compétences IDE/IPA — autonomie, anticipation
- Primo-prescription & ajustements thérapeutiques
- Structuration pratiques & culture qualité (PACQ)

CONCLUSION

Plus-value majeure sur la continuité et qualité des soins. Réduction hospitalisations évitables, réactivité accrue, suivi régulier et développement d'une culture qualité durable.

AXES D'AMÉLIORATION

→ Déployer des indicateurs standardisés (taux hospit., passages urgences, délai prescription)

→ Formaliser des synthèses locales venant servire les rapports d'activité des etablissements

→ Valoriser la dynamique de formation continue avec le médecin référent (raisonnement clinique, prévention)
→ Structurer le développement des compétences des équipes.

VERBATIMS TERRAIN

"J'étais à 150 %, je pense que c'est l'avenir, ce n'est pas que de la télémédecine mais hybride !"

Directrice — Secteur Handicap

"Le temps est restreint et c'est du temps qualitatif plus qu'en présentiel"

Infirmière coordinatrice — Secteur Séniors

"Aujourd'hui on travaille notre PACQ, il y a vraiment un suivi, une continuité"

Cadre de santé — Secteur Séniors

"Ça marche et ce n'est pas une question d'écran mais d'humain !"

Cadre supérieur de santé — Secteur Séniors

"Je prépare un master IPA, je m'éclate, ce sont de vrais échanges, on est ses yeux et ses oreilles au quotidien"

Infirmière — Secteur Handicap